



1

53. ARGANG | 01 • 2016

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

indhold

Udvikling af pædagogisk åbenhed for børns perspektiver og deltagelse i vuggestue og dagpleje

Legetræning kan udvikle og forbedre de sociale kompetencer for børn med problemer indenfor autismspektret og ADHD

Har alle, der har en opmærksomhedsforstyrrelse, AD/HD?

Gruppemetoden – et redskab til behandling af efterfødselsreaktioner

PPRs konsultative funktion: Følsomme relationer og professionelle identiteter på spil

Inklusion – Administration, tradition eller kvalitet?

Har alle, der har en opmærksomhedsforstyrrelse, AD/HD?



Blandt børn og unge er AD/HD (Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder) den hyppigst registrerede psykiatriske diagnose. Der er sket en stor udvikling fra ca. 1.000 børn og unge med diagnosen i 2001 til ca. 8.000 i 2011 (Due, 2014; Regeringens udvalg om psykiatri, 2013).

Det er imidlertid usikkert, i hvilken grad der reelt er sket en stigning i prævalensen, eller om den stigende prævalens skyldes ændringer i diagnosticeringspraksis, administrative forhold af organisatorisk art, som fx ændrede kommunale forhold vedrørende betingelser for tildeling af sociale ydelser og/eller øget kapacitet i børnepsykiatrien. Denne stærkt tiltagende diagnosticering af AD/HD er genstand for debat og blandt fagfolk hersker der fortsat uenighed om diagnosen (Skåderud, 2011).

Af Pia Pipenbring Hedegaard, mag.art.psych., aut.psykolog, faglig leder, UPCN (Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland)

Case Illustration

25-årig kvinde henvises til psykolog, fordi hun har svært ved at koncentrere sig i timerne og om at lave sine hjemmopgaver. Kvinden fortæller ved første samtale, at hun netop har brudt med sin kæreste gennem 3 år og er i gang med at etablere sig i egen lejlighed. Hun ser træt og slidt ud, men er meget talende til tider usammenhængende. Hun har tydeligvis et stort talepres. Hun har svært ved at forholde sig til/koncentrere sig om den psykoedukative del af behandlingen mod depression.

*Kvinden har endvidere konsulteret sin læge (praktiserende læge), som har igangsat medikamentel behandling mod **depression** med antidepressiva og anbefalet samtalebehandling ved psykolog. Kvinden påbegynder kognitiv terapi og modtager i alt 12 individuelle samtaler. Skolen tilbyder på den bag-*

grund en deltidssygemelding (dvs. at hun kun deltager i de fag, hun forventes at afslutte ved skoleårets afslutning). Efter 8 måneders behandling med antidepressiva vælger kvinden i samråd med sin læge at seponere den medikamentelle behandling mod depression, da effekten synes at udeblive. Samtaleforløbet ved psykolog afsluttes. Hverken den farmakologiske behandling, samtalebehandlingen eller deltidssygemelding har den ønskede effekt. Kvinden må afbryde den igangværende ungdomsuddannelse (HHX) pga. for meget fravær.

*Hun overføres til en uddannelse på et lavere fagligt niveau (HG). Kvinden oplever efterfølgende en periode med frygt for at forlade sit hjem, hvilket hun forsøger at undgå. Hun beskriver adfærd, der kan tolkes som undgåelsesadfærd, men også **panikangst** anfald, når hun*

trods sin angst. Hun erkender, at hendes undgåelsesadfærd og angst er overdreven og uden grund. Hun angiver tillige, at hun føler sig overvåget, men kan ikke beskrive af hvem, og hvorfor hun skulle overvåges. Hun føler ikke angst for at blive kritisk iagttaget af andre mennesker, men kan ikke **være i sin klasse uden at opleve angst.** På baggrund af manglende respons på behandling mod depression, vanskeligheder med at gennemføre en ungdomsuddannelse, panikangst og følelsen af at blive overvåget henvises hun til udredning ved psykiater, som giver hende diagnosen **AD/HD på baggrund af semistruktureret interview (DIVA)** og igangsætter behandling med methylphenidat. I forbindelse med indtagelse af methylphenidat bliver kvinden hypervigil. Hun klager over træthed og kvalme, men oplever ingen bedring af koncentrationen. Efter 9 dage vælger kvinden at stoppe den medikamentelle behandling mod AD/HD.

Ved sidste samtale hos psykologen (3 uger efter ophør med Ritalin) fremtræder kvinden uden opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder. Hun er sammenhængende i tale og talepresset er forsvundet. Hun deltager i undervisningen uden problemer og lave sine lektier. Adspurg om årsagen til denne markante ændring viser det sig, at kvinden den seneste måned har indledt et forhold til en mand. Forholdet synes at udvikle sig til en relation hun og han gerne vil bygge videre på. Samtidig fortæller kvinden, at hendes kognitive funktionsniveau har været svingende de seneste 5-6 år.

Hvilke diagnostiske overvejelser giver case illustrationen?

Patologisering af livsproblemer

Vi har skabt en konkurrence- og præstationskultur, hvor forventningerne om selvkontrol er øget både i arbejdsliv og i skole. Vores største udfordring er at håndtere en frihed, hvor man ikke kan tage sig selv for givet, men hvor man må præstere sig selv. På dem måde bliver man sin egen lykkes smed. Når man mislykkes, fyldes man med skam. I den proces er vi afhængige af andres syn på os for at fastsætte vores værdi – og uden værdsættelse fra andre kender vi ikke længere vores værdi. En støt kurs og et sikkert kompas hjælper ikke længere. At gøre sig synlig, skaffe sig adgang til den andens blik bliver en langt vigtigere kompetence (Ekeland, 2007).

“Presset på identitetskonstruksjoner og det manglende eksistensielle sikkerhetsnettet til den som ikkje lukkast har dessutan gjort slykerolla meir attraktiv enn før. I motsetnad til ein avgrunn av sosial skam ved å vere ingenting, tilbyr vi gjennom det aukande talet på diagnosar ein rett til å lide på legitimt vis.”(Ekeland, 2007).

Det, at unge oplever at have forskellige symptomer på psykisk lidelse, er imidlertid ikke ensbetydende med, at der foreligger en psykisk lidelse. Det afgørende er, om der også er tale om en væsentlig påvirkning af det daglige liv. For at det giver mening at tale om en psykiske lidelse, skal visse symptomer optræde sammen med længerevarende

og alvorlige vanskeligheder i forhold til at magte dagligdagens almindelige udfordringer. I forbindelse med vurdering af symptomer på psykisk lidelse erfare af unge kan/bør det overvejes, om de snarere er tegn på afmagt, hvor den enkelte reagerer forskelligt afhængig af individuelle forskelle i personlighed og dispositioner. Kombinationen af disse (følelsen af afmagt, personlighed og disposition for psykiske lidelse) og omstændigheder omkring den unge kan give en mental sårbarhed som kan resultere i egentlig psykisk lidelse (Caspi, 2014).

Den seneste blandt forskellige undersøgelser viser, at ca. 33 % (ca. 25 % unge mænd og 41 % unge kvinder) af de 16-24-årige oplever at være enten lidt eller meget generet af at føle sig deprimeret, uheldig eller nedtrykt. Andelen af 16-24-årige, der har følt sig lidt eller meget generet af ængstelse, nervøsitet, uro eller angst er steget fra 21 % i 2010 til 25 % i 2013. Der er sammenhæng mellem psykisk mistrivsel og læring, social funktion samt skolefravær, og psykisk mistrivsel i barndom og ungdom er forbundet med øget risiko for bl.a. depression og mistrivsel som voksen (Due, 2014).

Leder kvinden efter retten til at lide på legitim vis? Hvis ja, hvad er det så, hun ikke er lykkedes med? Hun er 25 år, forholdet til en partner gennem 3 år er ophørt, hun har problemer med at etablere sit nye hjem og må have støtte fra sin mor. Hun kæmper med at leve op til de faglige krav på den ungdomsuddannelse, hun er i gang med og flertallet af dem hun går i klasse med 5-6 år yngre end hun er. Der er mange grunde til, at hun kan opleve, at hen-

des identitet og eksistentielle sikkerhedsnet er under pres, at hun kæmper med følelsen af ikke at lykkes. I et forsøg på ikke at se disse fakta i øjnene kan man mistænke hende for – ubevist – at ønske sig en diagnose.

Søvnproblemer

Kunne der også være tale om søvnproblemer? Kvinden fortæller i forbindelse med anamneseoptagelsen, at hun har svært ved at falde i søvn fordi hun ligger og spekulerer over om det lykkes for hende at gennemføre sin uddannelse, om det lykkes hende at blive til "noget". Det betyder at hun ofte sover for lidt. Derfor vælger hun med jævne mellemrum at blive væk fra skole for at indhente sit søvnunderskud. Heller ikke på dette område adskiller hun sig fra andre unge. Blandt unge på 15-24 år sover hver fjerde mindre end 7 timer om natten. De har ofte eller meget ofte svært ved at falde i søvn. Der er sket en markant stigning i andelen af unge som har søvnproblemer, og som sover mindre end anbefalet, i perioden 1984 til 2010. Der synes at være en sammenhæng mellem utilstrækkelig nattesøvn og problemer i skolen, depression, lav selvtillid, dårlige karakterer og brug af rusmidler (Due, 2014). Kvindens klagebillede ligner de beskrevne symptomer på for lidt søvn, men er det en psykisk lidelse? Eller kan det føre til det? Og hvordan bør det behandles?

Emotionelle lidelser

Kvinden får, af sin praktiserende læge, diagnosen: Depression. En ikke usandsynlig diagnose hendes alder, køn og klagebillede taget i betragtning. Un-

dersøgelser tyder på, at forekomsten af børn og unge med depression, mani og angst er steget og debutalderen er formodentlig faldende. Der findes ingen monitorering på området, men angst- og depressionsforekomsten angives at ligge mellem 1,5-4 % og for OCD på mellem 0,5 og 4 %. Depression og angst optræder op til næsten fem gange hyppigere hos piger end hos drenge i pubertetsalderen (Due, 2014).

Var kvinden deprimeret, da forholdet til kæresten blev afviklet eller har kvinden udviklet en depression på grund af tabet af en kæreste/status (være i forhold)? Eller.... Årsagen/årsagerne til depressionen er imidlertid ikke vigtig for at stille diagnosen, men kan være betydningsfuld i forhold til behandling. Men fokus i behandlingen, herunder også i samtalebehandlingen er symptomlindring, psykoedukation, forebyggelse af tilbagefald og fastholdelse i den igangværende ungdomsuddannelse og ikke på at finde årsagen/årsagerne. Det afsluttede forhold og ændrede status berøres ganske perifert i begyndelsen af samtalebehandlingen. Men er der tale om skam? Skam over ikke at lykkes med at præstere sig selv (Ekeland, 2007). Hverken den medikamentelle eller den samtaleterapeutiske behandling fik den ønskede effekt (symptomlindring og fastholdelse af den igangværende ungdomsuddannelse). Spørgsmålene er: var udgangspunktet (diagnosen) korrekt? Var behandlingen korrekt?

Skizofreni

Kunne der være tale om skizofreni? Skizofreni rammer ca. 1 % af befolkningen. Den debuterer i en ung alder,

som reglen mellem 15 og 25 år, men kan begynde senere.

Prodromalfasen er præget af ukarakteristisk forværring af den psykosociale funktion, hvilket det opløste parforhold og kvindens ubehag ved at deltage i klasseundervisning kunne være et tegn på. Der ses endvidere affektive forandringer, som fx depression og panikangst, som kvinden søges behandlet for med SSRI-præparat, dog uden effekt og emotionelle forandringer såsom manglende lyst til skolegang, hvilket var tilfældet hos kvinden, og manglende lyst til fritidsinteresser; kvinden havde ingen, men hun formåede at opretholde sin fritidsbeskæftigelse som bartender. Opmærksomheds- og koncentrationsbesvær, angst og tvangsfænomener ses ligeledes i prodromalfasen (Freedman, 2003), hvilket også var en del af symptombilledet hos kvinden. Opmærksomheds- og koncentrationsbesvær var årsagen til at kvinden søgte læge og blev henvist til psykolog, fordi det var vanskeligt for hende at deltage i undervisningen og løse hjemmeopgaver.

Og endelig, kan det, at hun reagerer med hypervigilant i forbindelse med indtagelse af Ritalin ses som et tegn på skizofreni? Adskillige undersøgelser har vist, at methylphenidat og andre centralstimulerende lægemidler forøger risikoen for at inducere psykotiske episoder hos patienter, der allerede har fået diagnosen skizofreni (Dalsgaard et al., 2014). I Sundhedsstyrelsens produktresumé for Ritalin angives det, at patienter, der er diagnosticeret bl.a. med alvorlig depression, psykotiske symptomer, mani, skizofreni, ikke bør behandles med Ritalin (Sundhedssty-

relsen, 2015a) netop for at undgå at inducere psykotiske episoder hos patienterne. Kan kvindens svingende kognitive funktionsniveau, oplevelsen af at være overvåget og panikangst anfald være forsvarer til skizofreni?

AD/HD

Kvinden får på baggrund af et klinisk interview og DIVA 2.0 diagnosen AD/HD og der igangsættes medikamentel behandling med methylphenidat. I forbindelse med anamneseoptagelsen klager kvinden over opmærksomhedsforstyrrelse i forbindelse med deltagelse i undervisningen og tidvist i forbindelse med lektielæsning. Afgørende for fastholdelse af hendes opmærksomhed i forbindelse med lektielæsning er hendes interesse for opgaverne. I forbindelse med undervisningen har kvinden svært ved at fastholde sin opmærksomhed, primært fordi hun bliver forstyrret af sine tanker om hvordan det går med hendes søster og hendes mor samt med hvad de andre elever tænker om hende og det hun bidrager med i timerne. Kvinden fortæller, at disse tanker forstyrrer hendes koncentration. Adspurgt angiver kvinden, at hun godt kan fastholde sin opmærksomhed ved læsning af skønlitteratur, tv-udsendelser, bilkørsel og i forbindelse med sin fritidsbeskæftigelse (bartender). Kvinden opfatter sig selv som meget talende, og på grund af sin fritidsbeskæftigelse havende en god situationsforømmelse.

I forbindelse med det efterfølgende samtaleforløb registreres ingen opmærksomhedsforstyrrelser, men et stort talepres, og vanskeligheder med at fastholde hende i forbindelse med

psykoedukationen. Kvinden har tydeligvis et stort behov for at fortælle om de vanskeligheder hendes mor oplever i forhold til kvindens lillesøster, der har fået diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderline type og bl.a. om planlægningen af en nærtstående fødselsdag med 25 gæster, som hun har påtaget sig at arrangere. Kvinden er meget engageret i sin søsters behandling og i planlægningen af fødselsdagen. Sidstnævnte opgave løste hun uden problemer. Kvinden angiver, at hendes opmærksomhedsforstyrrelser har været til stede med jævne mellemrum de seneste 5-6 år. Der gennemføres en opmærksomhedstest (d2-test) som led i udredningen af hendes opmærksomhedsforstyrrelse. Resultatet af denne viser en koncentrationsydelse inden for normalområdet. Når vi sammenholder kvindens klager og beskrivelse af hendes opmærksomhedsforstyrrelse med AD/HD-diagnosen jf. DSM-5 (faktaboks 2), ses der et sammenfald af symptomer og klager. Det er imidlertid vigtigt at have for øje at psykiatriske diagnoser er symptomdiagnoser, dvs. at diagnosen blot er en kategorisering af symptomer. Psykiatriske diagnoser er ikke en præcisering af psykiatriske lidelser og de er uafhængig af årsager til disse. I diagnostisk øjemed er årsager som udgangspunkt ikke relevante, og det sammen gælder i behandlingen, hvor der primært er fokus på reduktion eller bedst af alt af fjernelse af symptomer. Reduktion eller fjernelse af symptomer på psykiatrisk lidelse ved hjælp af medikamentel behandling kombineret med psykoedukation fører imidlertid sjældent til bedret funktionsniveau

med mindre dette har været medind-
draget i behandlingen.

- AD/HD (attention-deficit hyperactivity disorder) anvendes i det amerikanske DSM-5-system.
- Tilstanden (hyperkinetisk forstyrrelse, AD/HD) defineres ud fra symptomerne opmærksomhedsproblemer, motorisk hyperaktivitet og impulsivitet
- Symptomerne synes relateret til de overordnede organiseringsfunktioner ("eksekutive funktioner"*) i centralnervesystemet.

*Samlebegreb for planlægning og kontrol af adfærd og handlinger, dømmekraft, fleksibilitet i tankegang og opnåelse af mål, evne til at bruge feedback til at ændre strategier samt selv-monitorering. Disse komplekse funktioner har subkomponenter og er dermed ikke lokaliseret til noget enkelt område af hjernen, men fælles for dem er, at de er kritisk afhængige af præfrontal cortex (Bjerg, 2011)

Faktaboks 1

DSM-V (APA, 2013)
Tilstandens varighed: mindst 6 måneder
Debutalder: <12år Børn op til 16 år skal have 6 eller flere af symptomerne Børn op til 17 år og voksne skal have 5 eller flere af symptomerne

Opmærksomhedsforstyrrelse (mindst 6 eller flere af følgende):

1. Har ofte svært ved at fæstne opmærksomheden ved detaljer eller laver skodesløse fejl i skolearbejde, på arbejdet eller i forbindelse med andre aktiviteter
2. Har ofte svært ved at fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg
3. Synes ikke at høre hvad der bliver sagt
4. Har ofte svært ved at følge instrukser eller fuldføre skolearbejde, opgaver eller pligter på arbejdspladsen (dvs. mister fokus, bliver afledt)
5. Kan ikke tilrettelægge arbejde eller aktiviteter
6. Undgår, afskyr eller er modvillig til at løse opgaver der kræver vedholdende opmærksomhed over lang tid (som fx skolearbejde eller lektier)
7. Mister ofte ting, der er nødvendige for opgaver eller aktiviteter (fx skolemateriale, blyanter, bøger, værktøj, punge, nøgler, papirer, briller, mobiltelefoner)
8. Lader sig let distrahere
9. Er glemsom i forbindelse med dagliglivsaktiviteter

Hyperaktivitet og Impulsivitet (mindst 6 eller flere af følgende):

1. Uro i hænder eller fødder, sidder uroligt
2. Forlader sin plads i situationer, hvor det forventes at blive siddende
3. Løber, klatrer, farer omkring på utilpasset måde (Unge og voksne kan føle sig rastløse)
4. Støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille
5. Excessiv motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre
6. Taler for meget, uden situationsfornemmelse
7. Svarer før spørgsmålet er afsluttet
8. Har ofte svært ved at vente på at det bliver hans/hendes tur
9. Afbryder eller maser sig på (både i samtaler og i spil/leg)

Adskillige af symptomerne er til stede i to eller flere situationer (dvs. hjemme, i skole eller på arbejde, sammen med venner og/eller pårørende; i andre aktiviteter)

Forstyrrelserne forårsager betydelige vanskeligheder eller vanskeliggør sociale, skole- og beskæftigelsesmæssige funktioner
Symptomerne må ikke skyldes Skizofreni eller andre psykotiske lidelser. Symptomerne må ikke bedre kunne forklares med andre mentale forstyrrelser (stemnings forstyrrelser, angstlidelser, dissociative lidelser eller personlighedsforstyrrelser)
Tre former for AD/HD kan forekomme: 1. En kombineret type, hvis der er tilstrækkeligt mange symptomer på både opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitet-impulsivitet 2. Opmærksomhedsforstyrrelse, hvis der ikke er tilstrækkeligt mange symptomer på hyperaktivitet-impulsivitetsforstyrrelse 3. Hyperaktiv-impulsivitetsforstyrrelse, hvis der ikke er tilstrækkeligt mange symptomer på opmærksomhedsforstyrrelse Børn op til 16 år skal have 12 eller flere af ovennævnte symptomer Børn op til 17 år og voksne skal have 10 eller flere af ovennævnte symptomer OBS: fordi symptomer kan ændre sig over tid, kan præsentationen også ændre sig over tid

Faktaboks 2

Men er AD/HD er en psykiatrisk lidelse, er den ikke snarere en ætiologisk heterogen lidelse, hvor både genetiske, neurokemiske, affektive, kognitive og sociale miljømæssige faktorer bidrager til den samlede årsag for lidelsen? Hvis det er tilfældet bør både udredning og behandling afspejle dette. Meget af den tilgængelige forskning peger på, at AD/HD er en hjernebaseret anormalitet i eksekutive funktioner i forbindelse med selv-regulering, arousal, motivation, kognitiv fleksibilitet og arbejdshukommelse, forårsaget af svigt i de dopaminerge neurale systemer ved fremkaldelse af normative belønningssystemer

mer i hjernens udvikling(Murray, 2008) og mange klinikere betragter vanskeligheder ved eksekutivfunktionen som et centralt symptom(Bjerg, 2011) for AD/HD.

Eksekutivfunktionen er et samlebegreb for planlægning og kontrol af adfærd og handlinger, dømmekraft, fleksibilitet i tankegang og opnåelse af mål, evne til at bruge feedback til at ændre strategier samt selv-monitivering. Disse komplekse funktioner har subkomponenter og er dermed ikke lokaliseret til noget enkelt område af hjernen, men fælles for dem er, at de er kritisk afhængige af præfrontal cortex (Bjerg, 2011).

Imidlertid viser en metaanalyse(Willcutt E.G., 2005) af 3.734 patienter med AD/HD sammenlignet med 2.969 raske kontrolpersoner, at der ganske vist var forskel på grupperne mht. forskellige eksekutive opgaver, men *effect size* var moderat (0,46-0,69) og mest udtalt mht. "response inhibition", "vigilance", arbejdshukommelse og planlægningsevne. De moderate *effect sizes*, og det at de eksekutive vanskeligheder ikke var et universelt træk for AD/HD-gruppen, viser, at disse vanskeligheder hverken er nødvendige eller tilstrækkelige til at definere AD/HD.

Det betyder, at diagnosen ikke kan stilles på baggrund af patientens eksekutivfunktionsniveau og patienten er afhængig af hvordan den der stiller diagnose forholder sig til patientens subjektive oplevelse af det der forhindrer ham eller hende i at fungere på arbejdsmarkedet/i uddannelsessystemet. Vi er med andre ord tilbage til udgangsspørgsmålet: Har alle, der har en

opmærksomhedsforstyrrelse, AD/HD? Svaret er nej, men hvorfor stiger antallet af mennesker, der får den diagnose? Der kan være mange grunde, og det er ikke hensigten med denne artikel/dette indlæg at undersøge dette, men derimod at drøfte med læserne om vi kan blive bedre til at diagnosticere de psykiatriske lidelser fx ved at kombinere viden fra tilgrænsende fagområder: neurobiologi, -psykologi, -kemi, -psykiatri?

AD/HD-diagnosen stilles i dag ikke på baggrund af direkte måling af hyperaktivitet, impulsivitet og manglende opmærksomhed, men på oplysninger om, hvordan almindelige udfordringer i hverdagen magtes (eksekutiv funktionen). Det er således et krav, at der som minimum skal optræde karakteristiske vanskeligheder svarende til enten impulsivitet/hyperaktivitet eller udtalte koncentrationsproblemer i flere sammenhænge, typisk både hjemme og i skolen. Diagnosen har endvidere indtil nu kun kunnet stilles, hvis vanskelighederne samlet set har en betydelig negativ effekt på skole- eller arbejdspræstation eller på relationer til andre (APA, 2013; Due, 2014).

Udredning og behandling af AD/HD hos børn og unge

Jf. Sundhedsstyrelsens Nationale kliniske retningslinjer (maj 2014) for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge – med fokus på diagnoserne “F90.0 Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed” og “F90 Opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet” i henhold til ICD-10 (WHO, 1994) anses det for god praksis at en diagnostisk standardudredning for

ADHD, hos børn og unge i alderen 6-18 år, er tværfaglig og tværsektoriel, og at den inkluderer følgende delelementer:

- Klinisk interview med anamnese
- Standardiserede ratingscales eller spørgeskemaer
- Indhentning af oplysninger om og evt. observation af barnets/den unges dagligdag
- Lægelig, somatisk undersøgelse
- Psykologisk undersøgelse (Sundhedsstyrelsen, 2014).

Udredning og behandling af AD/HD hos voksne

Jf. Sundhedsstyrelsens Nationale kliniske retningslinjer (januar 2015) for udredning og behandling af ADHD hos voksne – med fokus på diagnoserne “F90.0 Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed” og “F90 Opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet” i henhold til ICD-10 (WHO, 1994) anses det for god praksis, at en diagnostisk standardudredning inkluderer følgende delelementer:

- Ratingscales udfyldt af personen selv, fx ASRS v.1.1 (Adult Self-report Scale)
- Interview – helst med deltagelse af pårørende – med anamnese indeholdende systematisk indhentede oplysninger om personens udvikling samt psykiatriske symptomer og ledsagende vanskeligheder fra tidlig barndom til voksenalder samt evt. tidligere eller aktuelt misbrug. Endvidere indhentes oplysninger om personens sundhedsmæssige, sociale og økonomiske situation

samt uddannelses- og erhvervs-mæssige baggrund og daglige funktion

- Lægelig, somatisk undersøgelse
- Standardudredning af ADHD ud fra kriterierne i ICD-10 med anvendelse af en semistruktureret spørgeguide som fx DIVA 2.0 (Diagnostic Interview for ADHD in Adults). (Sundhedsstyrelsen, 2015b)

Diskussion

Mange psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser medfører kliniske opmærksomhedsforstyrrelser jf. figur 1, og tilsvarende eksekutive vanskeligheder. Det stiller store krav til dem/os der diagnosticerer, da diagnoser ofte (al-tid!?) styrer den efterfølgende behandlingen. Er vi godt hjulpet af De Nationale Kliniske Retningslinjer? Overordnet set ja, men der mangler en præcisering af hvilke standardiserede ratingscales og spørgeskemaer der bør anvendes og tilsvarende hvilke psykologiske tests der er relevante at gennemføre med henblik på at undersøge om de af patienten og dennes pårørende beskrevne klager kan afgøre hvilken, om nogen, diagnose, der kan stilles.

DIVA 2.0. som anvendes til udredning af voksne (18 år og opefter), stiller en række spørgsmål vedr. symptomer, der svarer til de vanskeligheder der er beskrevet som symptomer på AD/HD-diagnosen, men ikke entydigt og det er ofte vanskeligt for både den unge og deres forældre at huske 12-14 år tilbage og om de vanskeligheder den ung beskriver i dag også var til stede tidligere i et omfang der vanskeliggjorde skolegang og deltagelse i div. fritidsbeskæftigelser. Svarene fra de unge og

deres forældre er ofte bias i forhold om der ønskes en diagnose eller ikke, som svar på de kognitive og emotionelle vanskeligheder, der fik dem at søge læge/psykolog.

Mange af de symptomer, der er beskrevet i DSM-IV hørende under AD/HD eller ADD- diagnosen er også til stede ved andre psykiske lidelser som fx bipolær affektiv sindslidelse, emotionel affektiv sindslidelse blot for at nævne nogle. Ingen af de kognitive tests, der eksistere, kan skelne disse lidelsers kognitive vanskeligheder fra hinanden og på den måde hjælpe os tættere på en diagnose.

Spørgsmålet er om der er forskel på de opmærksomhedsforstyrrelser der ses hos mennesker med forskellige psykiatriske lidelser?

Opmærksomhedsforstyrrelser er imidlertid et vidt begreb, og afhængigt af patologien kan patienter være skadede i én eller flere opmærksomhedsfunktioner (Rosenberg, 2013). Årsagen eller årsagerne til opmærksomhedsforstyrrelser er imidlertid endnu uklare, mens grundlaget for opmærksomhed er klarere. Arousal og vigilitet styres af et netværk af nerver i formation reticularis, noradrenalinsystemet og amygdala (Rosenberg, 2013; Skårderud, 2011). Modsat arousal og vigilitet, som er medfødte funktioner, er opmærksomhed færdigheder, der skal læres. Det er ikke funktioner, der fremkommer ved hjernens naturlige modning og vækst (Goleman, 2013). Susan Hart og Hardy Sørensen postulerede tilbage i 2007 at *“Barnets personlighed og de affektive strukturer i nervesystemet konstrueres på baggrund af struk-*

turerede erfaringer med sig selv i samspil med andre.” (Carl, 2007).

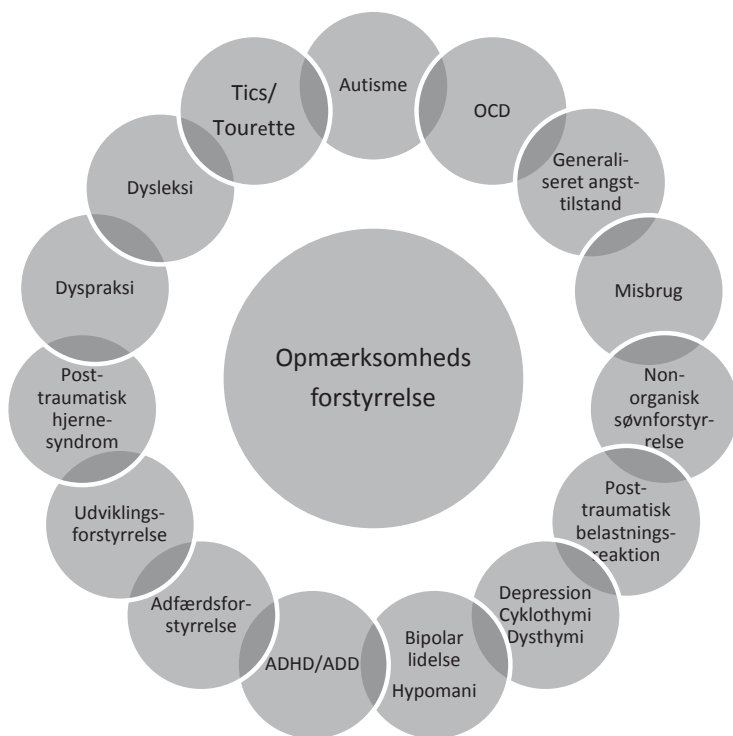
Case illustrationen og de efterfølgende diagnostiske overvejelser viser også, at kliniske opmærksomhedsforstyrrelser kan anskues forskelligt afhængigt af tid, faggruppe og speciale. Fx som udtryk for et ønske (ubevidst måske) om at få en diagnose i artiklen kaldet en patologisering af livsomstændigheder, et symptom på en affektiv lidelse (her depression) eller forvarslingssymptomer på skizofreni, hvilket er vigtigt at holde sig for øje,

da kvinden i case illustrationen får diagnose AD/HD. Skizofreni nævnes som en af flere differentialdiagnostiske lidelser, der skal tages i betragtning i forbindelse med diagnosticering af AD/HD (APA, 2013).

Disse er illustreret i nedenstående figur 1.

Konklusion

Alle, der diagnosticeres med en klinisk opmærksomhedsforstyrrelse, har ikke AD/HD, men opmærksomhedsforstyr-



Opmærksomhedsforstyrrelse

Oversigt/figur der viser hvilke organiske og psykiske lidelser der har opmærksomhedsforstyrrelse som et symptom

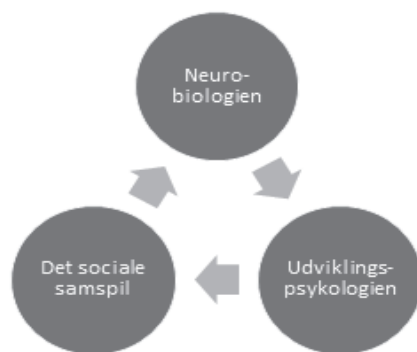
relser ses ved en række psykiatriske lidelser.

I en metaanalyse foretaget af Willcut E.G., 2005 konkluderes det, at eksekutive vanskeligheder, som anses for at være et kernesymptom ved AD/HD, hverken er en forudsætning for eller et tilstrækkeligt symptom til at forårsage alle former for AD/HD. De fleste undersøgelser, hvor man sammenligner AD/HD-patienter med raske kontrolpersoner, finder en *effekt size* for forskellen mellem grupperne mellem 0,5 og 1,0, hvilket vil sige, at der er mellem 30-50 % overlap mellem raske personers og AD/HD-patienters fordeling af resultater på de fleste test (Rosenberg, 2013). Eksekutive vanskeligheder ses ikke blot i forbindelse med psykiatriske lidelser, men også hos raske kontrolpersoner.

Perspektivering

Som en konsekvens af dette må forskningen inden for psykiatrien og psykologien forlade opdelingen mellem den neurobiologiske og psykodynamiske forklaringsmodel på psykiske *lidelser* og i stedet rette fokus på **sammenhængen** mellem neurobiologien, udviklingspsykologien og det sociale samspil i forhold til psykiske *forstyrrelser* i barn- og ungdom (se figur 2). Både i et forsøg på at forstå (diagnosticere) og behandle psykiske forstyrrelser hos børn og unge. Fokus bør i første omgang rettes mod at forstå problemadfærden som det bedst mulige svar på det den unge oplever i dets liv i samspil med andre og samtidig undersøge den unges psykiske udvikling og neurobiologi, dvs. at tage kompleksitet alvorlig.

Som det er i dag starter og slutter søgningen efter svar på problemadfærden alt for ofte ved biologien. Ofte finder man svar, som man spørger. Problemet med det er, at den unges adfærd kommer til at fremstå uafhængigt af den kontekst, som den har udviklet sig i. AD/HD-diagnosen bygger ikke på direkte måling af hyperaktivitet, impulsivitet og manglende opmærksomhed, hvilket øger risikoen for fejlagnostisering. Sundhedsstyrelsen angiver i deres Nationale Kliniske Retningslinjer for diagnosticering og behandling af børn og unge med AD/HD (Sundhedsstyrelsen, 2014), at der skal foretages psykologisk undersøgelse uden at angive hvilke(n).



Figur 2: Transdisciplinær videnskabs-tradition

Referencer

- APA. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)*. Washington, DC.
- Bjerg, J. (2011) *Gads Psykologilektikon* (3. ed., pp. 830): Gads Forlag.
- BPS. (2009). *Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Diagnosis and Management of*

- ADHD in Children, Young People and Adults. Leicester (UK): National Collaborating Centre for Mental Health (UK).*
- Carl, J. (2007). Bro over to forskningsområdet. Et interview med Hart og Sørensen. *Psykolog Nyt*, 23, 4.
- Caspi, A., Houts, R.M., Belsky, D.W., Goldman-Mellor, S.J., Harrington, H. Israel, S. et al. (2014). The p Factor: One General Psychopathology Factor in the Structure of Psychiatric Disorders? *Clin Psychol Sci*, 2(2), 19.
- Dalsgaard, S., Mortensen, P. B., Frydenberg, M., Maibing, C. M., Nordentoft, M., & Thomsen, P. H. (2014). Association between Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in childhood and schizophrenia later in adulthood. *European Psychiatry*, 29(4), 259-263. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2013.06.004>
- Due, P., Diderichsen, F., Meilstrup, C., Nordentoft, M., Obel, C. & Sandbæk, A. (2014). Børn og unges mentale helbred. Forekomst af psykiske symptomer og lidelser og mulige forebyggelsesindsatser (1. udgave ed., pp. 184). København: Vidensråd for Forebyggelse.
- Ekeland, T.-J. (2007). Psykoterapi – ein kulturkritikk. *Matrix*, 24, 115.
- Freedman, R. (2003). Schizophrenia. *New England Journal of Medicine*, 349(18), 1738-1749. doi: [doi:10.1056/NEJMr035458](https://doi.org/10.1056/NEJMr035458)
- Goldhammer, F., Moosbrugger, H. & Schweizer, K. (2007). On Serarability of Cognitive Abilities Rerated to Posner's Attention Components and Their Contributions to Conceptually Distinct Attention Abilities Related to Working Memory, Action Theory, and Psychometric Assessment. *European Psychologist*, 12(2), 15. doi: [10.1027/1016-9040.12.2.103](https://doi.org/10.1027/1016-9040.12.2.103)
- Goleman, D. (2013). *Focus – The hidden Driver of Excellence (I. Højelse, Trans.)*. New York, NY: HarperCollins Publisher.
- Hjerneskerådgivningen, N. T., Odense Kommune og 8 øvrige fynske kommuner. (2012). *Håndbog i Neuropædagogik*. Odense: Hjerneskerådgivningen.
- Kringelbach, M. (2008). *Den nydelsesfulde hjerne – nydelsens og begærets mange ansigter* (1. udgave ed.). København: Gyldendal.
- Murray, R. M., Kendler, K.S., McGuffin, P., Wessely, S. & Castle, D.J. (2008). *Essential Psychiatry* (4. ed.).
- Regeringens udvalg om psykiatri. (2013). *Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser – udvikling i diagnoser og behandling. Bilagsrapport 2* (pp. 256). København: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Rosenberg, R. V., P. (red). (2013). *Klinisk neuropsykiatri. Fra molekyle til sygdom*. (2. udgave ed.). Danmark: FADL's Forlag.
- Skåderud, F., Haugsgjerd, S., Stånicke, E. (2011). *Psykiatriboken* (1. udgave ed.): Gyldendal Akademisk.
- Sturm, W., & Zimmermann, P. (2000). Aufmerksamkeitsstörung *Lehrbuch der Klinischen Neuropsychologie. Grundlagen, Methoden, Diagnostik, Therapie* (pp. 345-365). Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Sundhedsstyrelsen. (2014). *Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge – med fokus på diagnosernes "forstyrrelse af af aktivitet og opmærksomhed" og "opmærksomhedsforstyrrelser uden hyperaktivitet" i henhold til ICD-10* København: Sundhedsstyrelsen.
- Sundhedsstyrelsen. (2015a). *Produktresumé for Ritalin 10 mg*.
- Sundhedsstyrelsen. (2015b). *Udredning og behandling af ADHD hos voksne – med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed samt opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet*. Sundhedsstyrelsen.
- Thomas, R., Sanders, S., Doust, J., Beller, E. Glasziou, P. . (2015). Prevalence of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis. *Pediatric.aappublications.org*. doi: [10.1542/peds.2014-3482](https://doi.org/10.1542/peds.2014-3482)
- Treisman, A. (1977). *Focused attention in the perception and retrieval of multidimensional stimuli* (01 Aug 1978 ed., Vol. 22, pp. 1-11). U Oxford, England: Psychonomic Society (, US); (, Germani).
- WHO. (1994). *ICD-10 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser – klassifikation og diagnostiske kriterier* (1. udgave ed.). København: Gyldendal Akademisk.
- Willcutt E.G., D., A.E., Nigg, J.T., Faraone, S.V., Pennington, B.F. (2005). Validity of Executive Function Theory of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analytic Review. *Biol Psychiatry*, 57(11), 10. doi: [10.1016/j.biopsych.2005.02.006](https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.02.006)